



亚急性甲状腺炎

(肉芽肿性甲状腺炎；亚急性肉芽肿性甲状腺炎；巨细胞性甲状腺炎)

作者：[Laura Boucai](#), MD, Weill Cornell Medical College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2026

亚急性甲状腺炎是甲状腺的急性炎症，很可能是病毒引起的。

(另见[甲状腺概述](#)。)

亚急性甲状腺炎通常突然起病。出现这种病时，炎症会使甲状腺过量释放甲状腺激素，导致[甲状腺功能亢进](#)，随后几乎总会出现短暂性的[甲状腺功能减退](#)，最终甲状腺功能恢复正常。

亚急性甲状腺炎的症状

起病时被许多病人称为“咽痛”的症状，而实际上被证明是颈部甲状腺疼痛。甲状腺的触痛变得越来越严重。疼痛可以从颈部的一侧转移到另一侧，延伸到下颌或耳部，当转动头部或吞咽时疼痛加重。亚急性甲状腺炎起病初期常被误诊为牙科疾病或咽部、耳部感染。

许多亚急性甲状腺炎患者感到极度疲乏。患者通常会出现低热（37°C 至 38°C）。

亚急性甲状腺炎患者最初可能出现[甲状腺功能亢进症状](#)，如心率和血压增加、出汗过多和感觉太热、手震颤（颤抖）以及紧张和焦虑，随后出现[甲状腺功能减退症状](#)，包括疲劳、体重增加、便秘、皮肤和头发干燥以及畏寒。

亚急性甲状腺炎的诊断

- 血液检测甲状腺功能
- 放射性碘甲状腺扫描和放射性碘摄取试验

亚急性甲状腺炎的诊断依据是患者的症状、体检和[甲状腺功能血液检查](#)的结果。如果患者有甲状腺功能亢进的症状，其血液 T4 水平应该偏高，TSH 水平应该偏低。随着甲状腺功能减退的发展，血液 T4 水平可能会下降到偏低水平，而 TSH 水平则可能升高。

有时可能很难区分亚急性甲状腺炎与 [Graves 病](#)，在这种情况下，医生会进行一次甲状腺扫描和放射性碘摄取试验。发生亚急性甲状腺炎时，炎症导致甲状腺摄取的放射性很少或完全没有，而发生格雷夫斯病时摄取量则会增加。

甲状腺超声检查也有助于诊断亚急性甲状腺炎。

亚急性甲状腺炎的治疗

- 有时使用缓解疼痛和炎症的药物

大部分亚急性甲状腺炎患者可以完全康复。通常这种甲状腺炎可在几个月内自行缓解，但有时复发，更少见的是由于甲状腺破坏过多而导致永久性甲状腺功能减退。

阿司匹林或其他非甾体类抗炎药（NSAID）能缓解疼痛和炎症。如果症状严重或使用抗炎药无法使其受控，医生可能建议使用泼尼松等类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇），并在 6 至 8 周内逐渐减少剂量。若突然或过早停用类固醇，症状通常会完全复发。

当甲状腺功能亢进状严重时，建议使用β受体阻滞剂。

如果甲状腺功能减退的症状严重或甲状腺功能减退转变为永久性疾病，则可能需要使用合成型甲状腺激素（左旋甲状腺素）。